LÝ THUYẾT · MẮT

BÀI 1 Đỏ mắt: tiếp cận chẩn đoán và điều trị

Biên soạn lại từ bài giảng 1. Red Eye - Diagnosis & Treatment.pdf (14 trang) · Giải thích dễ hiểu, kèm 2 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐẠI CƯƠNG
2. BA CÂU HỎI ĐỂ TIẾP CẬN ĐỎ MẮT
3. ĐỎ MẮT KHÔNG ĐAU, THỊ LỰC BÌNH THƯỜNG
4. ĐỎ MẮT CÓ ĐAU: NGHĨ TỚI NGUYÊN NHÂN NẶNG
5. BỆNH LÝ PHẦN PHỤ KHÁC

Học xong bài này, bạn cần: nhận ra dấu hiệu cảnh báo của đỏ mắt; biết hướng tới nguyên nhân thường gặp; nắm nguyên tắc xử trí ban đầu và khi nào phải chuyển tuyến.

1. ĐẠI CƯƠNG

- Đỏ mắt là **một trong những triệu chứng nhãn khoa thường gặp nhất**.
- Nguyên nhân rất đa dạng: từ bệnh **lành tính, tự khỏi** (viêm kết mạc, xuất huyết dưới kết mạc) đến tình trạng **cấp cứu đe dọa thị lực** (viêm loét giác mạc, glôcôm góc đóng cấp).
- Việc của người thầy thuốc tuyến đầu không phải là chẩn đoán thật chi tiết, mà là **nhận diện dấu hiệu cảnh báo** để **xử trí ban đầu** và **chuyển tuyến kịp thời**.

Hiểu nhanh: mắt đỏ vì các mạch máu ở bề mặt nhãn cầu giãn ra hoặc vỡ ra. Câu hỏi quan trọng nhất luôn là: bệnh chỉ ở **bề mặt** (kết mạc, thường nhẹ) hay đã vào **bên trong** (giác mạc, mống mắt, nhãn áp, thường nặng)?

Hai kiểu đỏ cần phân biệt

Kiểu đỏ	Nhìn thấy	Gợi ý
Cương tụ kết mạc	Đỏ nhiều ở vùng cùng đồ, **nhạt dần khi về gần giác mạc**	Bệnh ở bề mặt: **viêm kết mạc**
Cương tụ rìa	Vòng đỏ sẫm **sát quanh rìa giác mạc**	Bệnh ở sâu: **viêm loét giác mạc, viêm mống mắt – thể mi, glôcôm góc đóng cấp**

2. BA CÂU HỎI ĐỂ TIẾP CẬN ĐỎ MẮT

Bài giảng chia đỏ mắt theo 3 câu hỏi, hỏi lần lượt:

- **Cấp hay mạn?** Mới xuất hiện hay đã kéo dài.
- **Một mắt hay hai mắt?** Bệnh toàn thân, dị ứng, nhiễm virus thường bị 2 mắt; chấn thương, bệnh khu trú thường 1 mắt.
- **Có đau hay không đau? Đau** là dấu hiệu nghĩ tới nguyên nhân **nặng hơn**.

Nhóm	Không đau	Đau
Mạn, 2 mắt	Co rút mi, lồi mắt, song thị: **bệnh mắt nội tiết** (Basedow)	Mỏi mắt, nóng rát, ngứa: **khô mắt** (viêm kết giác mạc khô)
Mạn, 1 mắt	**Hở mi** (nhắm mắt không kín): chuyển khám chuyên khoa **khẩn**	**Bất thường vị trí mi**: quặm, lật mi, lông xiêu

Nhóm	Không đau	Đau
Cấp, 2 mắt	Phù kết mạc, theo mùa, tiếp xúc dị nguyên: **viêm kết mạc dị ứng**	Sau hàn điện: **viêm giác mạc do tia**; hoặc tiết dịch trong, sợ sáng, co quắp mi: **viêm kết mạc virus**, chuyển chuyên khoa
Cấp, 1 mắt	Mắt lồi đập theo mạch: **dò động mạch cảnh – xoang hang** (chuyển khẩn); hoặc mảng máu đỏ xuất hiện đột ngột: **xuất huyết dưới kết mạc**	Nghi **dị vật, thủng nhãn cầu** hoặc **cơn glôcôm góc đóng cấp** (nhãn cầu **cứng như đá**): **cấp cứu**

Cảnh báo: đỏ mắt kèm **đau nhức, nhìn mờ, sợ ánh sáng, cương tụ rìa, đồng tử méo hoặc không co khi chiếu đèn, mủ tiền phòng, nhãn cầu cứng**, hoặc có **chấn thương, dị vật** → không tự điều trị kéo dài, **chuyển chuyên khoa mắt ngay**.

3. ĐỎ MẮT KHÔNG ĐAU, THỊ LỰC BÌNH THƯỜNG



Hình 1. Hai nguyên nhân đỏ mắt không đau thường gặp. Xuất huyết dưới kết mạc là một mảng máu khu trú; viêm kết mạc là đỏ lan tỏa do giãn mạch.

Viêm kết mạc

- **Do dị ứng: ngứa** là chính, chảy nước mắt, **phù kết mạc cả hai mắt**.
  - Điều trị: **ngưng tiếp xúc dị nguyên**; **kháng histamine** tại chỗ và toàn thân.
  - Dự phòng: **thuốc ổn định dưỡng bào** hoặc **kháng thụ thể H1**.
- **Do khô mắt:** cảm giác cộm, khô rát, đỏ nhẹ.
  - Điều trị bằng **nước mắt nhân tạo, gel bôi trơn** để tránh biến chứng **viêm giác mạc sợi**.
- **Do yếu tố cơ học:** bất thường mi (**lật mi, hở mi**) làm bề mặt mắt bị cọ xát, khô liên tục, tổn thương biểu mô.
  - Nhỏ thuốc chỉ đỡ tạm; muốn khỏi phải **phẫu thuật chỉnh hình mi**.
- **Do vi khuẩn** (Staphylococci, Streptococci):
  - Đỏ mắt, **dính mi khi ngủ dậy**, tiết dịch **mủ nhầy**, tạo **vảy vàng quanh mi**.
  - **Không đau, không nhìn mờ.**
  - Nếu xuất hiện **đau, sợ ánh sáng, co quắp mi** → nghĩ bệnh đã **ảnh hưởng giác mạc**.
  - Điều trị: **kháng sinh nhỏ mắt nhóm fluoroquinolones**.
- **Do virus** (chủ yếu **Adenovirus**, dễ **lây thành dịch**):
  - **Khởi phát ở một mắt rồi lan sang mắt còn lại.**
  - Tiết dịch **nhầy trong**, ngứa, cộm xốn, **nổi hạch trước tai**.
  - Thường **tự giới hạn trong khoảng 2 tuần**.

- Tránh tiếp xúc, **rửa tay sạch** để không lây; **nước mắt nhân tạo** giúp giảm triệu chứng.

Mẹo nhớ: Vi khuẩn → mủ, dính mi. Virus → nước trong + hạch trước tai, lây thành dịch. Dị ứng → ngứa, 2 mắt.

Xuất huyết dưới kết mạc

- **Cơ chế:** các mạch máu nhỏ dưới kết mạc có **thành mỏng, dễ vỡ**; máu tràn ra nằm dưới lớp kết mạc trong suốt.
- Xuất hiện **đột ngột**, **không đau**, **không ảnh hưởng thị lực**; thường sau **ho, hắt hơi mạnh, rặn** (nghiệm pháp **Valsalva** làm tăng áp lực tĩnh mạch).
- Yếu tố liên quan: **tăng huyết áp**, **rối loạn đông máu**, **dùng thuốc chống đông**.
- **Xử trí:**
  - **Đo huyết áp ngay** để loại trừ cơn tăng huyết áp cấp cứu.
  - Máu thường **tự hấp thu trong 2–4 tuần**, không cần nhỏ thuốc đặc hiệu.
  - Tư vấn bệnh nhân **khám tim mạch**.

Vì sao trông đáng sợ mà lại lành? Máu chỉ nằm ở lớp màng ngoài cùng, không vào trong nhãn cầu, nên mắt vẫn nhìn rõ và không đau. Điều cần lo không phải là con mắt mà là **huyết áp và đông máu** của bệnh nhân.

4. ĐỎ MẮT CÓ ĐAU: NGHĨ TỚI NGUYÊN NHÂN NẶNG



Hình 2. Bốn nguyên nhân đỏ mắt có đau cần nhận ra sớm. Viêm loét giác mạc và glôcôm góc đóng cấp là cấp cứu nhãn khoa.

Viêm loét giác mạc – CẤP CỨU NHÃN KHOA

- **Cơ năng:** cộm xốn, **cảm giác dị vật**, **đau lan lên hốc mắt**, **sợ ánh sáng**, chảy nước mắt, **nhìn mờ**.
- **Thực thể:** mi **co quắp**, sưng nề; **cương tụ rìa**; **tổn thương ở giác mạc** (ổ trắng đục); có thể có **mủ tiền phòng** (mức mủ trắng ở đáy tiền phòng).
- Chi tiết xem **Bài 3**.

Viêm củng mạc

- Thường gặp ở **phụ nữ 40–60 tuổi**, **có bệnh toàn thân** đi kèm; **50% bị cả 2 mắt**.
- Ba thể:
  - **Lan tỏa ≈ 40%**: nhẹ nhất.
  - **Dạng hạt (nốt) ≈ 45%**.
  - **Hoại tử**: hiếm, **đau +++**, viêm trầm trọng → **mỏng củng mạc, có thể thủng nhãn cầu**.
- **Cơ năng:** đau nhức, nhìn mờ, chảy nước mắt, sợ ánh sáng.
- **Thực thể:** kết mạc **cương tụ khu trú hoặc lan tỏa**.

Viêm mống mắt – thể mi

- **Cơ năng: đau, đỏ, sợ ánh sáng**.
- **Thực thể:**
  - **Cương tụ rìa**.
  - **Tủa mặt sau giác mạc** và fibrin rải rác ở nội mô giác mạc (các chấm trắng bám mặt trong giác mạc, như trong hình).
  - **Nhãn áp thường thấp** (có thể bình thường hoặc tăng).
  - **Phản ứng thể mi (+)**: ấn nhẹ vùng thể mi qua mi trên thấy đau.

Glôcôm góc đóng cấp – CẤP CỨU NHÃN KHOA

- **Cơ năng:** đau nhức dữ dội, đỏ, nhìn mờ; **nhìn đèn thấy quầng nhiều màu sắc**; **buồn nôn, nôn ói**.
- **Thực thể: cương tụ rìa**; giảm thị lực, **nhãn áp tăng rất cao** (sờ nhãn cầu **cứng như đá**); **tiền phòng nông**; **đồng tử giãn méo, phản xạ ánh sáng (–)**.
- Chi tiết xem **Bài 5**.

> **Cảnh báo:** bệnh nhân glôcôm cấp hay **nôn ói, đau đầu** nên dễ bị chẩn đoán nhầm là bệnh tiêu hóa hoặc thần kinh. Gặp người đau đầu, nôn mà **một mắt đỏ, nhìn mờ** → nhớ **sờ nhãn áp và nhìn đồng tử**.

So sánh nhanh 4 bệnh đỏ mắt có đau

Bệnh	Dấu hiệu "chìa khóa"
Viêm loét giác mạc	Ổ đục trên giác mạc, có thể mủ tiền phòng
Viêm củng mạc	Phụ nữ trung niên, bệnh toàn thân, đau nhức sâu
Viêm mống mắt – thể mi	Tủa mặt sau giác mạc, **nhãn áp thường thấp**
Glôcôm góc đóng cấp	Quầng màu, nôn ói, **nhãn áp rất cao**, đồng tử giãn méo

5. BỆNH LÝ PHẦN PHỤ KHÁC

- **Chắp, lẹo:** viêm nhiễm vi khuẩn cấp tại các **tuyến bã nhờn / mồ hôi ở bờ mi**.
  - Biểu hiện: **nốt sưng đỏ, đau khu trú** ở mi.
  - Điều trị: **chườm ấm + thuốc mỡ kháng sinh**.
- **Bất thường vị trí mi:**
  - **Quặm mi (entropion):** bờ mi **lộn vào trong** → lông mi cọ vào giác mạc.
  - **Lật mi (ectropion):** bờ mi **lộn ra ngoài** → hở mi, khô rát, chảy nước mắt.
  - Cả hai cần **phẫu thuật chỉnh hình mi**.

- **Dò động mạch cảnh – xoang hang:**
  - Mắt đỏ với **mạch máu kết mạc giãn to, ngoằn ngoèo**.
  - **Lồi mắt đập theo nhịp mạch**, nghe có **tiếng thổi trong hốc mắt**.
  - Yêu cầu **chuyển viện chụp MRI mạch máu khẩn cấp**.

> **Ghi nhớ cả bài:** đỏ mắt **không đau, nhìn rõ** → thường là bệnh bề mặt, điều trị được tại tuyến đầu. Đỏ mắt **có đau, nhìn mờ, cương tụ rìa** → bệnh ở sâu, là **cấp cứu**, chuyển chuyên khoa sớm.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ bài giảng 1. Red Eye - Diagnosis & Treatment.pdf. Hình minh hoạ lấy từ bài giảng, nhãn đã dịch sang tiếng Việt. Đối chiếu bài giảng gốc khi cần chi tiết.